

DOSSIER CLINICO INTERNISTICO

Data di redazione: 14/09/2026 | Redatto da: Dott. Pietro Spitaleri Timpone, Medico Specializzando in Medicina Interna

ANAGRAFICA E MOTIVO DELLA VALUTAZIONE

Paziente: Rossi, Mario

Età: 68 anni

Sesso: maschile

Motivo principale del consulto: Riordino della documentazione clinica

IN ANAMNESI

- Ipertensione arteriosa essenziale (nota da ca. 15 anni), in trattamento cronico
- Diabete Mellito tipo 2 (diagnosi nel 2018), attualmente in buon compenso glicemico (HbA1c recente 7.1%)
- Scompenso cardiaco a frazione di eiezione conservata (ecocardiogramma di controllo di marzo 2026 documentante FEVS 55%, rimodellamento ventricolare sinistro concentrico, disfunzione diastolica di grado II). Precedente episodio di scompenso cardiaco acuto (Classe NYHA II) ricoverato nel novembre 2025 presso il Policlinico di Roma; durante il ricovero veniva sottoposto anche a TC coronarica che non ha documentato stenosi emodinamicamente significative.
- Nefropatia iniziale su base ipertensiva/metabolica (creatinina stabile intorno a 1.2 mg/dL, eGFR CKD-EPI ~ 65 mL/min/1.73m²).

Non note allergie a farmaci o alimenti.

Allergia stagionale a graminacee.

Ex fumatore di circa 5 sigarette al giorno per 10 anni. Ha smesso da 20 anni.

Consumo di alcolici occasionale (1 bicchiere di vino durante il weekend).

TERAPIA DOMICILIARE

Ramipril 5 mg 1 compresse al mattino (Ipertensione / nefroprotezione), Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa al mattino (Controllo della frequenza cardiaca), Empagliflozin 10 mg 1 compressa al mattino (Controllo glicemico / protezione cardio-renale), Metformina 850 mg 1 compressa a pranzo e 1 a cena, Atorvastatina 20 mg 1 compressa la sera (Prevenzione secondaria / profilo lipidico).

Non assume integratori.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE COMPLESSIVO

Peso corporeo: 70 kg.

Altezza: 170 cm.

BMI (Body Mass Index): 24.2

Effettua attività fisica regolare (camminata 3 volte a settimana per circa 1 ora su tapis roulant).

Lavora tuttora come ragioniere.

ESAMI IN VISIONE (DAL PIÙ RECENTE AL MENO RECENTE)

- Laboratorio (Data: 02/09/2026):** Glicemia a digiuno: 124 mg/dL, HbA1c: 7.1%, Creatinina: 1.21 mg/dL (eGFR 64 mL/min), Azotemia: 48 mg/dL, Na: 140 mEq/L, K: 4.5 mEq/L (elettroliti nella norma), Colesterolo Totale: 175 mg/dL, HDL: 48 mg/dL, LDL: 95 mg/dL, Trigliceridi: 140 mg/dL, Emocromo: Hb 14.2 g/dL, Leucociti e Piastrine nella norma.
- Esame urine (Data: 02/09/26):** Negativo per proteinuria significativa.
- Visita Cardiologica (Data: 15/03/2026):** Confermata stabilità clinica in NYHA II. Indicazione a proseguire la terapia medica ottimizzata e a monitorare i valori pressori domiciliari.
- Ecocardiogramma (Data: 10/03/2026):** Ventricolo sinistro non dilatato, ipertrofia parietale concentrica. Frazione di eiezione (FEVS) 55%. Alterazione del rilassamento miocardico (disfunzione diastolica di II grado). Sezioni destre nei limiti. VCI non dilata, collassabile.

CONCLUSIONI

Buon compenso clinico.

Si consiglia:

- Proseguire regolare follow-up cardiologico presso il proprio centro o specialista di riferimento (annualmente)
- Proseguire regolare follow-up diabetologico presso il proprio centro o specialista di riferimento (annualmente)
- Utile valutazione nefrologica in via elettiva

Si rilascia la seguente documentazione clinica per avvantaggiare la raccolta dell'anamnesi da parte degli specialisti o del medico di Medicina Generale curante.

Nota informativa / Disclaimer: Questo documento costituisce un esempio illustrativo di come viene strutturato il dossier clinico all'interno della piattaforma FiloClinico. Le informazioni e i dati clinici riportati sono di fantasia e non si riferiscono a un paziente reale.